PROVÃO M1 2019/1:
REUMATO, ORTOPEDIA, GERIATRIA, FISIATRIA E CIR. PLÁSTICA

6. Quais são atividades instrumentais de vida diária?
   a) .
   b) telefonar, gerir recursos financeiros, usar transporte público
   c) .
   d) .

7. Homem com aumento de edema de joelho foi prescrito AINE e começou a se queixar de epigastralgia. Para o edema de joelho foi passado um diurético que causou hipocalemia, sendo administrado K+, o que piorou epigastralgia. (tem uma sequência de medicamentos e efeitos adversos).Como chamamos esse efeito:
   A. Efeito dominó
   B. Prescrição em cascata
   C. Interação medicamentosa
   D. Ineficácia Terapêutica

8. O que deve ser EVITADO na desprescrição:
   A. Retirar medicamentos preventivos independente da expectativa de vida
   B. Retirar medicamentos sintomáticos, mesmo que sintomas já tenham melhorado
   C. Retirar vários medicamentos inapropriados ou de alto risco de uma só vez
   D. Retirar medicamentos psicotrópicos reduzindo a dose lenta e gradualmente

9. Mulher, 78 anos, diabética, perdeu 6kg em 4 meses, apresenta fraqueza, fadiga, dificuldade em subir escadas. Ao teste de preensão palmar obteve resultado de 10kg. Circunferência de panturrilha : 31cm. No caso em questão a paciente apresenta:
   A. Provável sarcopenia
   B. Sarcopenia confirmada
   C. Não apresenta sarcopenia
   D. Dados insuficientes para diagnóstico

10. Mulher, 75 anos, sedentária, caiu 3x. Medidas ambientais.

11. Queimadura indolor, aspecto polvilhado, vermelho vivo, nacarado, sem bolhas. Classificação?
   A. 1º grau
   B. 2º grau sup.
   C. 2º grau prof.
   D. 3º grau

12. 8 anos, masculino, dor súbita no joelho Esq. após futebol, piorando há 5 dias, deambulação claudicante. Ao ex. físico: edema 2+ e aumento de temperatura.

A. Pedir RX ?
B. Pioartrite, mas pedir RX após 10 dias
C. Via de contaminação é drenagem de osteomielite aguda de metáfise intra-articular.
D. Tratamento é cirúrgico, limpeza, eletiva.

13. Masc., 75, ca de próstata há 2 anos, finalizou tto com QT . Prostatectomia. Lombalgia contínua, sem fator de melhora ou piora, sem irradiação p/ MMII. Não melhorou com fisioterapia nem relaxante muscular. A dor piorou.

A. Imagem, … dor compressiva.
B. Investigar metástase para coluna
C. RX de coluna (+S e +E)
D. Metástase para coluna é pouco provável.

14. Questão de pé torto congênito
perguntava o tratamento:

a)
b)
c)
d) conservador = gesso semanal por 6 semanas + órtese de manutenção noturna por 4 anos (dennis brown)
- cirúrgico = quando conservador nã o corrige

15. Neuroplasticidade - conceito

a)
b)
c)
d)

16. Classificação de Herring para doença de Perthes, o tipo

a) a - 50% achatamento pilar lateral
b) b - 70%
c) b - 60%
d) c - >50% de achatamento do pilar lateral

17. Escoliose idiopática do adolescente

a) feminino, 11 - 18 anos
b) masculino, 11 - 18 anos
c) feminino, 12 - 25 anos
d) masculino, 12 - 25 anos

18. sobre o diagnóstico de trauma de extremidades, é correto:

a) fratura é uma incongruência articular
b) luxação é uma lesão direta das partes moles ou osso com hematoma
c) entorse é uma solução de continuidade do osso
d) lesão miotendínea é uma impotência funcional por ruptura

25. Mulher de 72 anos com osteoporose. Após avaliação médica foi diagnosticado sarcopenia. Quais os critérios para este diagnóstico?

a) Diminuição da massa muscular e diminuição da força
b) Diminuição da força muscular e alto perfil físico
c) Massa muscular normal e diminuição das enzimas musculares
d) Fraqueza muscular e elevação das enzimas musculares

26. Homem de 80 anos com osteoartrite no joelho direito em uso de bengala. Quais são as orientações para este paciente?

a) Durante a marcha, a bengala deve ser posicionada no degrau no membro superior esquerdo
b) Para descer uma escada, a bengala deve ser posicionada no degrau, primeiramente. Então, deve-se apoiar o MIE e, finalmente, o MDF, o qual suportará o peso do corpo.
c) Para levantar de uma cadeira, a bengala deve ser posicionada na frente do corpo, primeiramente. Em seguida, deve-se apoiar sobre a mesma inclinando o corpo para frente e levantar.
d) Para deambular, a bengala deve avançar simultaneamente com o membro inferior esquerdo.

27. Homem de 27 anos refere dor e edema em joelho D há 4 semanas associado a inchaço bilateral dos dedos. Exame mostra artrite no JD, dactilite e exame genitourinário normal. Qual a principal hipótese diagnóstica?

a) Artrite reativa
b) Artrite reumatóide
c) Gota
d) Artrite séptica

31. Acerca dos AINEs:
I - O AINEs possuem como reação adversa gastrite e afecções do TGI.
II - São AINEs: dipirona, corticosterona, loratadina e paracetamol.
III - Esta classe de medicamentos inibe a atividade da COX. A COX 1 é constitutiva, e produz prostaglandinas da homeostasia. A COX 2 é ativada em processos inflamatórios.
IV - Todos os AINEs são formados por ácido forte e base forte e por isso geram muitos efeitos adversos.
V - Esta classe pode apresentar propriedades anti inflamatórias, analgésicas e antipiréticas.

a) I, II, III
b) I, III e V

c) I, II e IV
d) I, III e IV

32. Sobre os glicocorticóides e seu mecanismo de ação marque a alternativa incorreta:
a) Os glicocorticóides são derivados do colesterol e são capazes de atravessar livremente a membrana plasmática.
b) Aumenta a transcrição de proteínas inflamatórias IL 2, IL3, IL4, IL6, IL8, IL 12, interferon gama e TGF alfa.
c) Após entrar na célula, os glicocorticóides se ligarão no receptor de glicocorticóides e depois se encaminharão para o núcleo celular. No DNA, o glicocorticoide ligado ao receptor afetará a transcrição gênica.
d) Os glicocorticóides indiretamente promovem a inibição da enzima fosfolipase A2, essencial para produção do ácido araquidônico.

33. Qual o fármaco padrão para o tratamento de AR (artrite reumatóide)?
a) Sulfassalazina
b) Leflunomida
c) Difosfato de cloroquina
d) Metotrexato

34. Laboratório de anemia no idoso
I. O exame com melhor custo/benefício e maior poder de discriminação entre anemia ferropriva e da anemia de doença crônica no idoso é a dosagem de ferro.
II. O exame com melhor custo/benefício e maior poder de discriminação entre anemia ferropriva e da anemia de doença crônica no idoso é a Ferritina.
III. A contagem de reticulócitos é um exame muito útil para diferenciar a anemia ferropriva da megaloblástica, muito comum no idoso.
IV. O sangue oculto nas fezes deve ser solicitado ao idoso se apresentar anemia microcítica e hipocrômica com anisocitose.
Quais afirmativas são verdadeiras?

39. Questão de patologia sobre tumor de partes moles, perguntava em relação ao sarcoma:
a) tem metástase hematogênica
b) biópsia só se > 5 cm
c) mais frequente em menores de 10 anos
d) apresenta células fusiformes

40. Questão de imagenologia perguntando as funções dos métodos de imagem,

41. Quais os métodos de imagem mais usados em afecções osteoarticulares?

42. São características do estudo radiográfico, exceto:

GABARITO COMENTADO | PROVÃO M1 2019/1

Reumatologia · Ortopedia · Geriatria · Fisiatria · Cirurgia Plástica

Critério de elaboração. Foram preservadas as questões efetivamente presentes (24 itens numerados de maneira descontínua). Respostas antigas e a página exclusiva de gabarito foram desconsideradas. As soluções abaixo refletem revisão técnica independente; se a questão não tem conteúdo suficiente, isto é explicitado.

Como interpretar: “com ressalva” = alternativa mais provável, mas enunciado impreciso; “não determinável” = não há dados/opções para atribuir letra; “ambígua” = mais de uma resposta defensável. As referências numeradas constam no final deste apêndice.

Gabarito resumido

Q6	B	Q7	B	Q8	A e C (ambígua)
Q9	A	Q10	Não determinável	Q11	D (com ressalva)
Q12	A (apenas como exame inicial)	Q13	B	Q14	D apenas como opção registrada
Q15	Não determinável	Q16	D	Q17	A
Q18	D (aproximada)	Q25	A	Q26	A (somente o lado; redação imprecisa)
Q27	A (mais provável)	Q31	B	Q32	B
Q33	D	Q34	II seguramente; IV não obrigatória	Q39	A
Q40	Não determinável	Q41	Sem letra (alternativas ausentes)	Q42	Conceito: radiografia simples não é multiplanar

Principais itens problemáticos: Q8 (duas opções evitáveis); Q10, Q15, Q40–42 (alternativas ou enunciados ausentes); Q11, Q12, Q14 e Q26 (respostas com limitações); Q34 (afirmação sobre pesquisa de sangue oculto não deve ser interpretada como obrigação universal).

Comentários por questão e por alternativa

Questão 6 — B

A. Não consta texto da alternativa A no documento; impossível julgá-la.

B. Correta. Telefonar, gerir dinheiro e usar transporte são atividades instrumentais da vida diária (AIVD), assim como preparar refeições e fazer compras.

C. Alternativa não transcrita; não é possível examiná-la.

D. Alternativa não transcrita; não é possível examiná-la.

Observação clínica ou limitação: Apenas B possui conteúdo verificável. Não se presume a redação das demais alternativas.

Referências: [1].

Questão 7 — B

A. Efeito dominó é termo inespecífico e não o nome técnico do fenômeno descrito.

B. Correta. O efeito adverso de um fármaco é tratado com outro e gera novas prescrições e efeitos indesejados: prescrição em cascata.

C. Uma interação pode causar dano, mas o eixo do enunciado é tratar sucessivamente eventos adversos com novos medicamentos.

D. Não se descreve apenas falta de eficácia: há iatrogenia progressiva.

Referências: [2].

Questão 8 — A e C (ambígua)

A. Também deve ser evitada: a decisão de retirar medidas preventivas depende de objetivos terapêuticos, risco/benefício e expectativa de vida; não se deve fazê-lo indistintamente.

B. Suspender medicamentos sintomáticos pode ser apropriado após resolução dos sintomas, com avaliação de recorrência e necessidade de redução gradual; não é proibido por definição.

C. Também deve ser evitada como conduta rotineira: suspender vários fármacos potencialmente perigosos ao mesmo tempo dificulta atribuir sintomas de retirada e controlar riscos. Exceções existem em situações urgentes.

D. Conduta geralmente apropriada: psicotrópicos com risco de abstinência costumam requerer retirada gradual e individualizada.

Observação clínica ou limitação: A e C são defensáveis como respostas. Sem critério adicional, a questão não tem resposta única segura.

Referências: [3].

Questão 9 — A

A. Correta. A força de preensão palmar de 10 kg está abaixo do ponto de corte para mulheres (<16 kg no EWGSOP2), caracterizando sarcopenia provável.

B. Para confirmar sarcopenia é necessário demonstrar baixa quantidade/qualidade muscular, usualmente por DXA ou bioimpedância. Panturrilha isolada não confirma o diagnóstico.

C. Incorreta diante da fraqueza objetivada por dinamometria.

D. Há dados suficientes para classificar como provável, embora não para confirmar a sarcopenia.

Referências: [4].

Questão 10 — Não determinável

Observação clínica ou limitação: Consta somente: mulher de 75 anos, sedentária, três quedas e pedido de medidas ambientais. Não há alternativas. A conduta baseada em evidências inclui revisar tapetes e obstáculos, assegurar boa iluminação, instalar barras de apoio, usar calçados estáveis e avaliar força, equilíbrio e medicamentos; nenhum item pode receber letra.

Referências: [10].

Questão 11 — D (com ressalva)

A. Queimadura superficial costuma ser dolorosa e eritematosa, sem perda total de sensibilidade.

B. Segundo grau superficial costuma ser muito doloroso, úmido e frequentemente com bolhas.

C. Segundo grau profundo pode ter sensibilidade reduzida e aspecto pálido, mas ainda preserva parte da derme e muitas vezes apresenta bolhas.

D. Mais compatível com a combinação de indolor, nacarado e sem bolhas, típica de espessura total (terceiro grau).

Observação clínica ou limitação: A expressão “vermelho vivo” é discordante do aspecto clássico de queimadura profunda e limita a certeza. Examinar perfusão/sensibilidade e evolução.

Referências: [5].

Questão 12 — A (apenas como exame inicial)

A. Radiografia imediata do joelho e ossos adjacentes é pertinente no diagnóstico inicial de criança com dor, edema e calor, particularmente após prática esportiva.

B. Não se deve esperar dez dias para investigar suspeita de artrite séptica: eventual infecção articular exige avaliação urgente.

C. Disseminação de osteomielite adjacente é possível, mas não é a via obrigatória nem pode ser afirmada para o joelho com os dados existentes.

D. Se houver artrite séptica, o tratamento não é limpeza eletiva; exige abordagem urgente, amostra sinovial e antibioticoterapia conforme gravidade.

Observação clínica ou limitação: A é a opção mais aceitável entre as transcritas, mas radiografia isolada NÃO exclui artrite séptica. Considerar artrocentese, hemoculturas, PCR, ultrassom e avaliação ortopédica conforme a suspeita.

Referências: [6], [15].

Questão 13 — B

A. Alternativa truncada; parece mencionar imagem e dor compressiva, mas não é possível afirmar qual conduta integral foi proposta.

B. Correta. Dor lombar persistente e progressiva em paciente com câncer de próstata é sinal de alarme para metástase vertebral, exigindo investigação por imagem apropriada.

C. Radiografia convencional pode mostrar alterações, mas não é suficiente para afastar metástase ou compressão neural quando a suspeita clínica é relevante; RM é preferível conforme cenário.

D. Incorreta. Câncer de próstata frequentemente metastatiza para o esqueleto axial.

Observação clínica ou limitação: Se houver déficit neurológico, disfunção esfincteriana ou dor sugestiva de compressão medular, a avaliação é emergencial.

Questão 14 — D apenas como opção registrada

A. Alternativa ausente no arquivo.

B. Alternativa ausente no arquivo.

C. Alternativa ausente no arquivo.

D. O registro cita gessos semanais e órtese de abdução por anos, núcleo do método de Ponseti. Contudo, a sequência está abreviada: frequentemente há tenotomia percutânea do Aquiles e a órtese costuma ser contínua nos primeiros meses e depois noturna/nas sonecas.

Observação clínica ou limitação: Não é possível comparar D com alternativas omitidas. A cirurgia extensa fica reservada a deformidades refratárias ou recidivas selecionadas.

Referências: [7].

Questão 15 — Não determinável

A. Alternativa ausente.

B. Alternativa ausente.

C. A expressão “a alternativa correta era a que a professora deu na aula” é anotação editorial, não texto de uma alternativa.

D. Alternativa ausente.

Observação clínica ou limitação: Neuroplasticidade é a capacidade do sistema nervoso de modificar conexões, organização estrutural e função em resposta a experiências, aprendizado, lesão e reabilitação. Não é possível atribuir letra sem as opções originais.

Referências: [8].

Questão 16 — D

A. No grupo A, o pilar lateral mantém sua altura, e não perde 50%.

B. O grupo B não é definido especificamente por 70% de achatamento; deve manter mais da metade da altura original.

C. O grupo B não corresponde a 60% de perda de altura, o que já excederia o limiar do grupo C.

D. Correta. O grupo C corresponde a mais de 50% de perda/colapso da altura do pilar lateral.

Referências: [9].

Questão 17 — A

A. Correta entre as apresentadas: escoliose idiopática do adolescente é mais comum em meninas durante o crescimento puberal, geralmente entre 10 anos e a maturidade esquelética.

B. Meninos também podem ser acometidos, mas com frequência menor.

C. A faixa etária até 25 anos não caracteriza a definição usual de escoliose idiopática do adolescente.

D. Incorreta tanto pela predominância masculina alegada quanto pela faixa etária.

Questão 18 — D (aproximada)

A. Fratura é perda de continuidade do osso, não incongruência articular.

B. Luxação significa perda de congruência articular, não simples contusão de partes moles.

C. Entorse é lesão capsuloligamentar por torção; solução de continuidade do osso define fratura.

D. Mais próxima. Rupturas miotendíneas podem causar perda de função; porém lesões miotendíneas também podem ser parciais e não obrigatoriamente provocar impotência completa.

Observação clínica ou limitação: A alternativa D é aceita por exclusão, com ressalva à generalização.

Questão 25 — A

A. Correta. O diagnóstico confirmado de sarcopenia requer redução da força muscular e evidência de baixa massa/qualidade muscular.

B. Força reduzida não combina com “alto perfil físico” como definição diagnóstica.

C. Massa normal e enzimas musculares reduzidas não constituem os critérios de sarcopenia.

D. Elevação de enzimas musculares indica investigar lesão ou doença muscular, não é critério de sarcopenia.

Referências: [4].

Questão 26 — A (somente o lado; redação imprecisa)

A. O uso na mão esquerda está correto para osteoartrite dolorosa do joelho direito; porém a frase sobre “degrau” durante a marcha está incompleta ou inadequadamente redigida.

B. Errada: ao DESCER escadas, bengala e membro comprometido (direito) vão primeiro ao degrau inferior; depois avança o esquerdo, mais forte.

C. Errada: levantar-se da cadeira deve utilizar braços da cadeira e membros inferiores de forma segura; não se recomenda puxar ou se apoiar inicialmente na bengala à frente do corpo.

D. Errada: bengala na mão esquerda deve avançar junto ao membro inferior DIREITO, e não ao esquerdo.

Observação clínica ou limitação: Nenhuma alternativa descreve integralmente a técnica correta de maneira inequívoca; a letra A é apenas a mais próxima. Melhor formulação: bengala na mão esquerda, avançando com a perna direita.

Referências: [10].

Questão 27 — A (mais provável)

A. Mais provável. Oligoartrite assimétrica de membro inferior e dactilite são compatíveis com artrite reativa, embora falte antecedente infeccioso documentado.

B. Artrite reumatoide costuma cursar com poliartrite simétrica persistente de pequenas articulações e dactilite não é típica.

C. Gota pode atingir o joelho, mas dactilite bilateral e quadro subagudo não a tornam a principal hipótese sem confirmação de cristais.

D. Artrite séptica deve ser excluída se houver suspeita clínica de infecção, mas não explica bem a dactilite bilateral crônica descrita.

Observação clínica ou limitação: Há incerteza etiológica; artrite psoriásica e outras espondiloartrites também entram no diferencial, mas não constam das opções.

Questão 31 — B

A. Incorreta porque inclui II: corticosterona e loratadina não são AINEs e paracetamol não é AINE clássico.

B. Correta. I é verdadeira (efeitos gastrointestinais); III é didaticamente correta com ressalvas (COX-1 tem funções constitutivas e COX-2 pode ser induzida); V é verdadeira (efeitos analgésicos, antipiréticos e anti-inflamatórios).

C. Incorreta: inclui II e IV, ambas falsas.

D. Incorreta por incluir IV: AINEs não são todos compostos por ácido e base fortes e tal justificativa não explica seus eventos adversos.

Observação clínica ou limitação: Nota: COX-2 também possui expressão constitutiva em alguns tecidos; a dicotomia é simplificação didática.

Questão 32 — B

A. Verdadeira: glicocorticoides derivam do colesterol e difundem-se através de membranas celulares.

B. Incorreta e, portanto, resposta. Glicocorticoides em geral reprimem a transcrição de mediadores pró-inflamatórios, e não a aumentam.

C. Verdadeira: após ligação ao receptor intracelular, o complexo modula transcrição de genes no núcleo.

D. Verdadeira em termos gerais: glucocorticoides inibem etapas da via do ácido araquidônico, inclusive indiretamente a fosfolipase A2 por mediadores como anexina A1.

Referências: [14].

Questão 33 — D

A. Sulfassalazina é DMARD convencional eficaz, opção em situações selecionadas, não o fármaco âncora preferencial da maioria dos casos.

B. Leflunomida é alternativa válida quando metotrexato não é adequado ou tolerado.

C. Cloroquina tem papel limitado e maior preocupação com toxicidade; não é tratamento-padrão inicial.

D. Correta. Metotrexato é DMARD convencional âncora no tratamento inicial de AR com atividade moderada/alta, conforme ACR.

Observação clínica ou limitação: Em doença de baixa atividade e situações especiais, o agente inicial pode variar. O enunciado pede o padrão geral.

Referências: [11].

Questão 34 — II seguramente; IV não obrigatória

I. Falsa. Ferro sérico varia com inflamação e horário, isoladamente tem pouca capacidade para diferenciar anemia ferropriva de inflamatória.

II. Verdadeira como regra prática: ferritina é marcador central do estoque de ferro, embora possa elevar-se como reagente de fase aguda.

III. Falsa. Reticulócitos refletem resposta eritropoiética, não discriminam especificamente anemia ferropriva de megaloblástica.

IV. Imprecisa. Na suspeita de anemia ferropriva em pessoa idosa, deve-se investigar etiologia, inclusive sangramento gastrointestinal, frequentemente com endoscopia indicada; pesquisa de sangue oculto NÃO é teste obrigatório que

substitua a investigação.

Observação clínica ou limitação: O arquivo NÃO inclui alternativas combinatórias; a resposta anterior foi retirada. Afirmativa II é a única inequivocamente adequada no sentido literal. A IV pode ter utilidade contextual, mas seu “deve” universal é inadequado.

Referências: [12].

Questão 39 — A

A. Correta. Sarcomas de tecidos moles frequentemente se disseminam por via hematogênica, particularmente para os pulmões.

B. Incorreta. Critérios para investigação/biópsia incluem lesões profundas, crescentes, suspeitas por imagem ou com tamanho relevante; o limiar de 5 cm não é exclusivo.

C. Incorreta. Sarcomas de partes moles, no conjunto, são mais frequentes em adultos; alguns subtipos predominam na infância.

D. Incorreta como generalização: vários sarcomas podem ter morfologia fusiforme, mas outros são pleomórficos, epitelioides ou de células pequenas.

Referências: [13].

Questão 40 — Não determinável

Observação clínica ou limitação: O registro informa apenas que havia uma questão sobre funções dos métodos de imagem, SEM enunciado técnico e SEM alternativas. Não é possível reconstruir a pergunta nem conferir uma letra. Em termos gerais: radiografia avalia estruturas ósseas; ultrassonografia, tecidos moles e derrames; TC, cortical óssea e anatomia complexa; RM, medula óssea, cartilagens, ligamentos e tecidos moles.

Questão 41 — Sem letra (alternativas ausentes)

Observação clínica ou limitação: Restou somente a pergunta sobre métodos de imagem mais usados; o texto “R: D) Raio-X e TC” era gabarito preexistente e foi excluído da prova. Na prática, radiografia, ultrassonografia, tomografia computadorizada e ressonância magnética têm aplicações amplas em afecções osteoarticulares. Sem o conjunto original de opções, não é rigoroso escolher uma dupla ou letra específica.

Questão 42 — Conceito: radiografia simples não é multiplanar

Observação clínica ou limitação: O arquivo registra a pergunta “características do estudo radiográfico, exceto”, mas não as alternativas, apenas um gabarito antigo removido. A radiografia convencional é projeção bidimensional obtida com radiação ionizante; realizam-se preferencialmente duas incidências ortogonais. Aquisição multiplanar é característica sobretudo de TC/RM, não da radiografia simples. Não atribuir letra sem opções.

Referências consultadas

Diretrizes, consensos e documentos de instituições médicas foram priorizados. Os links são consultáveis no arquivo digital; a seleção não significa que todos os itens possuam evidência de igual qualidade.

[1] Escala de Lawton e Brody: atividades instrumentais — Merck Manual.
https://www.merckmanuals.com/professional/multimedia/table/lawton-instrumental-activities-of-daily-living-scale

[2] Prescribing cascade: conceito e prevenção — Rochon & Gurwitz, BMJ 1997.
https://www.bmj.com/content/315/7115/1096

[3] Deprescribing in Older People: guideline summary — Medical Journal of Australia, 2026.
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC13054209/

[4] Sarcopenia: revised European consensus (EWGSOP2) — Age and Ageing, 2019.
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6322506/

[5] Burn Patient Referral Guidelines e classificação de queimaduras — American Burn Association.
https://www.ameriburn.org/burn-care-team/resources/guidelines-for-burn-patient-referral

[6] Artrite bacteriana aguda em crianças: diagnóstico e tratamento — PIDS/IDSA, 2023.
https://www.idsociety.org/practice-guideline/acute-bacterial-arthritis-in-pediatrics2/

[7] Clubfoot: técnica de Ponseti, tenotomia e órtese — AAOS OrthoInfo.
https://www.orthoinfo.org/diseases--conditions/clubfoot/

[8] Neuroplasticity: fundamentos e definição — StatPearls / PubMed.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32491743/

[9] Classificação de Herring na doença de Perthes — Pediatric Orthopaedic Society of North America.
https://posna.org/physician-education/study-guide/legg-calve-perthes-disease

[10] Uso adequado de bengalas e escadas — MedlinePlus / NIH.
https://medlineplus.gov/ency/patientinstructions/000343.htm

[11] Guideline para tratamento da artrite reumatoide — American College of Rheumatology, 2021.
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9273041/

[12] Avaliação gastrointestinal da anemia por deficiência de ferro — American Gastroenterological Association, 2020.
https://gastro.org/clinical-guidance/gastrointestinal-evaluation-of-iron-deficiency-anemia/

[13] Sinais de alarme em sarcomas de tecidos moles — SEOM Clinical Guideline / PMC.
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5138243/

[14] Mecanismos anti-inflamatórios da anexina A1 — PubMed review.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15060718/

[15] Radiologia de suspeita de artrite séptica/osteomielite — ACR Appropriateness Criteria.
https://acsearch.acr.org/docs/3094201/Narrative/